EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69738
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-25 12:47:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DAMIAN WENSESLAO GUTIERREZ HERMOSILLA			RUN	: 5.297.864-5
F.Nac	: 01-05-1943	Edad	: 80 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	:		
Fecha Ingreso	: 2023-08-24	Fecha Egreso	: 2023-08-25 12:47:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R56.8-OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
- Compromiso de conciencia en estudio. comicial vs sincope
- Traqueobronquitis
- Antecedentes: ACV 2017, hipertensión arterial, Dislipidemia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R56.8-OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Medicamentos de uso cronico:
- Amlodipino 10 mg, 1 comp al día
- Carvedilol 6,25 mg 1 comp cada 12 horas
- Ferrovitaminico 1 comp al día
- Furosemida 40 mg 1 comp al día
- Losartan 50 mg cada 12 horas

Diestro mRS 3
Paciente con antecedentes de ACV 2017, hipertensión arterial, dislipidemia. Vive solo. Previo a hospitalización con al menos 3 días de sensación febril y síntomas respiratorios.
Ulitma vez visto bien el 22/08/23, encontrado por cuidadora en suelo, con relagación de esfínteres y vomito.
Ingresa a HSC febril, con PA y FC normal. HGT 92 mg/dL. Se describe GCS 15, sin otros hallazgos, CK total alta.
Se realizó RX de torax que no evidenció focos de condensación. Al examen neurológico con paresia secuelar BC derecha. Sin otros hallazgos. Se realizó TC de encéfalo sin contraste en que se evidenció lesion de aspecto secuelar frontoparietal izquierda.
Se hospitaliza para seguimiento, se indicó levetiracetam ajustado a función renal, se mantiene mas de 24 joras asintomático en cuanto a lo neurológico.
Se mantiene con tos productiva por lo que se decide alta con hospitalización domicliaria para kinesioterapia respiratoria y tratamiento antibiótico.

PLAN DE MANEJO:

Holter de ritmo en forma ambulatoria.
EEG en forma ambulatoria.
No usar por ahora quetiapina ni carvedilol
Kinesioterapia motora y respiratoria
Control neurología posterior a alta.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen liviano hiposódico
3. Receta magistral Vitamina D3 50.000 UI 1 comp por semana por 6 semanas.. C
4. Aspirina 100 mg, 1 comp al día, vía oral.
5. Atorvastatina 20 mg, 1 comp al día, vía oral.
6. Levetiracetam 500 mg, 1/2 comp cada 12 horas, vía oral.
7. Losartan 50 mg, 1 comp cada 12 horas, vía oral.
8. Ceftriaxona 1 gramo, 2 FA al día por 5 días, posterior traslape oral
9. Bromuro Ipratropio 2 puff cada 6 horas + SOS con aerocámara.
10. Holter de ritmo en forma ambulatoria.
11. EEG en forma ambulatoria.
12. No usar por ahora quetiapina ni carvedilol
13. Kinesioterapia motora y respiratoria
14. Control neurología posterior a alta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Estudio complementario.
25/08/23 Creat 2.2, MDRD 28.9, Uremia 77, ELP 141/3.5/111, Hb 9.9, Hto 29.2, Leuco 7500, plaq 191.000, VHS 12, PCR 54.1. INR 1.16, TTPa 29. TSH 5.27, T4L 0.87, VitB12 513. VitD menor 2. OC no inflamatoria.

OBSERVACIONES:

Al examen de alta.
FC 59 lpm, PA 128/68 mmHg, T° 36.8°C, Sat 93 amb, HGT 114
MP presente, sibilancias espiratorias
- Mental: orientado parcialmente en tiempo y espacio, inatento, sin alteracion de lenguaje, disartria leve
- PFC derecha
- Hemiparesia derecha M4+ con plantar extensor derecho
- Sensitivo normal.
- Coordinacion normal
- Signos meningeos negativos.

MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO